便中シャルコー・ライデン結晶の検出が診断契機となった好酸球性十二指腸炎の１例

◎大江 可奈子[1)]、伊藤 英史[1)]、吉田 光徳[1)]、西尾 祐貴[1)]、宮本 康平[1)]、大嶋 剛史[1)]
医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院[1)]

【はじめに】シャルコー・ライデン結晶（Charcot-Leyden crystal：CLC）は、喘息をはじめとしたアレルギー疾患や寄生虫感染症などで認められる、好酸球性炎症を示唆する古典的所見である。今回、便中 CLC の報告を契機に好酸球性消化管疾患（EGIDs）を疑い、好酸球性十二指腸炎の診断に至った症例を経験したため報告する。

【症例】14 歳、女性。第 1 病日：腹痛と下痢が出現した。第 2 病日：近医を受診したが症状改善なく、同日当院救急外来を受診した。血液検査では炎症反応の上昇は認めず、腸炎または機能性腹痛として内服加療された。第 8 病日：右下腹部痛の増悪を認め、精査目的に入院となった。入院時の血液検査では WBC 7100/μl、好酸球 21.3%、好酸球数 1512/μl、CRP 0.02mg/dl であった。尿検査、CT 検査、MRI 検査では明らかな異常所見を認めなかった。

【経過】好酸球増多が持続していることから、寄生虫感染症を含めた鑑別を目的に便検査が追加された。便潜血・便中好酸球・寄生虫卵はいずれも陰性であったが、集卵法による鏡検中に CLC を認めた。CLC は好酸球由来結晶であり、寄生虫感染のみならず EGIDs などの好酸球性疾患でも認められることを臨床側へ報告したところ、炎症性腸疾患などの下部消化管疾患に加え、EGIDs も鑑別にあげられた。EGIDs では症状部位と病変部位が一致しない場合があることから、下腹部症状主体ではあったものの、上部消化管を含めた内視鏡検査が施行された。生検では十二指腸粘膜を中心に好酸球浸潤を認め、好酸球性十二指腸炎と診断された。

【考察】便中 CLC は EGIDs に特異的な所見ではないものの、好酸球増多を伴う消化器症状症例においては、上部消化管を含めた精査を検討する契機となり得る。また、集卵法は直接法と比較して背景残渣が少なく観察性に優れ、検体量も多いことから、CLC 検出率向上に寄与した可能性が考えられた。

【結語】好酸球増多を認める消化器症状症例では、寄生虫感染症の鑑別のみならず、CLC 検出を含めた便検査を実施することが EGIDs 診断の一助となる可能性が示唆された。

連絡先：0566-21-2450